HOSPITAL SAN RAFAEL

HC 889214

Epicrisis - Resumen de egreso hospitalario

Paciente:	ROSA ELENA VALENCIA MONTOYA
Edad:	71 años
Fecha de ingreso:	02/09/2026
Fecha de egreso:	09/09/2026
Servicio:	Medicina Interna - Piso 4

MOTIVO DE CONSULTA

Paciente remitida por cuadro de cinco días de tos con expectoración amarillenta, fiebre cuantificada hasta 38.9 °C, malestar general y dificultad respiratoria progresiva que limita la marcha corta.

ENFERMEDAD ACTUAL

Refiere inicio con odinofagia y rinorrea, con posterior aparición de tos productiva, escalofríos y disnea de esfuerzo. Consultó a urgencias por empeoramiento de la disnea y saturación de oxígeno de 90% al aire ambiente. Niega dolor torácico, hemoptisis, edema de miembros inferiores o viajes recientes.

ANTECEDENTES

Hipertensión arterial desde hace 15 años en manejo con losartán. Hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina. No fumadora. Sin alergias medicamentosas conocidas. Esquema de vacunación para influenza completo.

EXAMEN FÍSICO AL INGRESO

TA 138/84 mmHg, FC 102 lpm, FR 24 rpm, T 38.4 °C, SatO2 90% ambiente. Alerta, orientada, con tiraje intercostal leve. Ruidos respiratorios con crépitos en base pulmonar derecha. Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. Abdomen blando, sin dolor. Extremidades sin edema.

DOCUMENTO DE EJEMPLO - DATOS FICTICIOS

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Día 1: Se inicia oxígeno suplementario por cánula nasal a 2 L/min y antibioticoterapia empírica con ampicilina sulbactam intravenosa. Radiografía de tórax con consolidación en lóbulo inferior derecho. Se solicitan hemocultivos, hemograma y proteína C reactiva.

Día 2: Persiste fiebre en picos, con mejoría parcial de la disnea. Leucocitosis de 15.200 con neutrofilia. Proteína C reactiva elevada. Dímero D negativo; con base en ello y en el cuadro clínico se descarta tromboembolismo pulmonar.

Día 3: Hemocultivos sin crecimiento a las 48 horas; se descarta sepsis y no se requiere traslado a unidad de cuidados intensivos. Mantiene saturación de 94% con oxígeno a 1 L/min.

Día 4: Afebril por más de 24 horas. Se suspende oxígeno suplementario con saturación de 95% al aire ambiente. Tolera la vía oral.

Día 5: Control de laboratorio con descenso de leucocitos a 9.800 y de la proteína C reactiva. Se rota a antibiótico oral.

Día 6 y 7: Evolución favorable, deambula sin disnea, sin fiebre. Radiografía de control con resolución parcial de la consolidación. Se programa egreso.

PARACLÍNICOS RELEVANTES

Hemograma de ingreso: leucocitos 15.200, hemoglobina 12.8 g/dL, plaquetas 276.000. Creatinina 0.9 mg/dL. Glucosa 104 mg/dL. TSH 3.1 mUI/L. Gases arteriales con hipoxemia leve sin acidosis. Electrocardiograma en ritmo sinusal sin cambios isquémicos.

DIAGNÓSTICO DE EGRESO

1. Neumonía adquirida en la comunidad de lóbulo inferior derecho, resuelta. 2. Hipertensión arterial. 3. Hipotiroidismo.

CONDICIÓN AL EGRESO

Estable, afebril, sin requerimiento de oxígeno, tolerando la vía oral y con buena movilidad.

MEDICAMENTOS AL EGRESO

- Amoxicilina/ácido clavulánico 875/125 mg - 1 tableta cada 12 horas por 5 días
- Levotiroxina 75 mcg - 1 tableta cada mañana en ayunas
- Losartán 50 mg - 1 tableta cada 24 horas

RECOMENDACIONES Y CONTROL

Control por consulta externa de Medicina Interna en 10 días con radiografía de tórax. Reposo relativo, hidratación abundante. Consultar a urgencias si reaparece fiebre, dificultad respiratoria o dolor torácico.

Dra. CLAUDIA M. IBARRA
Medicina Interna
Reg. 54871